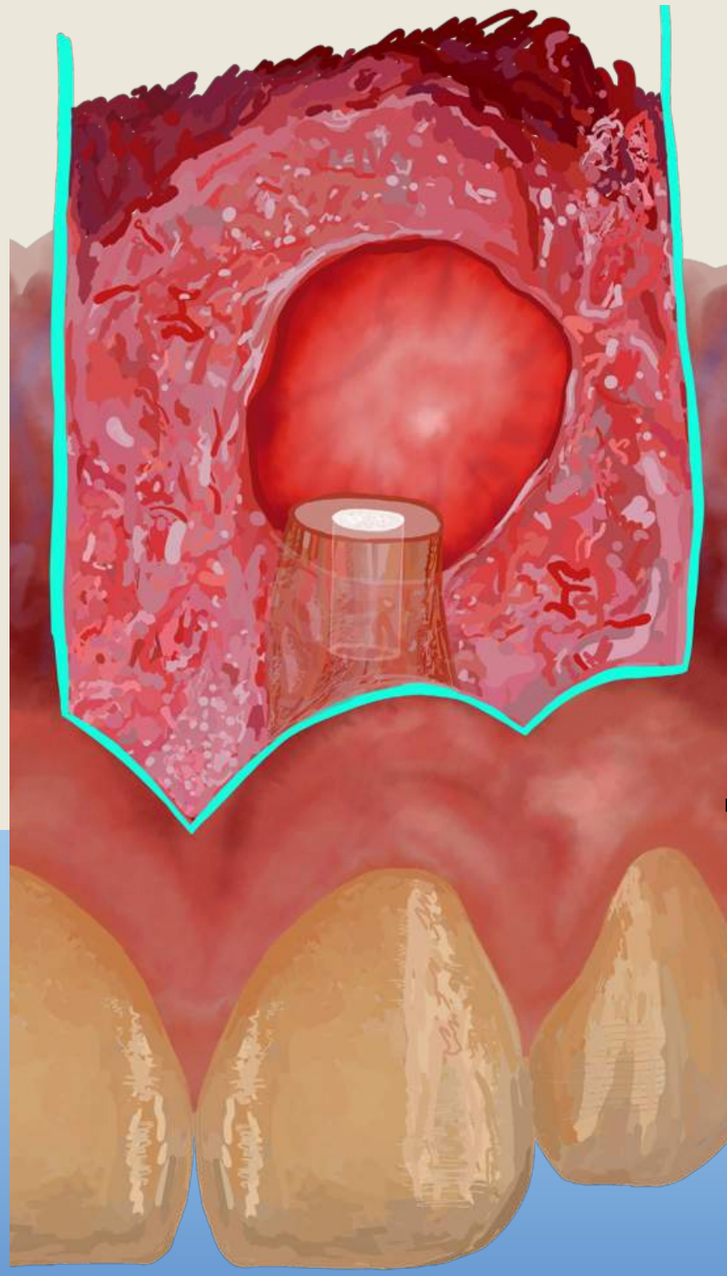
01

OBČASNÍK

první
2023



České endodontické společnosti

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

právě se do vašich rukou dostalo první číslo bulletinu České endodontické společnosti. Rádi bychom jeho prostřednictvím s vámi sdíleli novinky nejen z české endodoncie. A to jak formou referátů z přednášek a publikovaných článků či vlastních kazuistik, tak i doporučení naší odborné společnosti. Zároveň v bulletinu najdete informace o spolkové činnosti, abychom přiblížili průběh našich setkání členům, kteří se nemohli zúčastnit, a připomněli a nalákali vás na nadcházející akce.
Na počátku letošního roku ukončili svoji činnost ve výboru jeho dlouholetí aktivní členové – otec zakladatel Luděk Peřinka, Dan Černý, Soňa Hüttnerová, Simona Šaglová a Honza Šváb. Členové, kterým z velké části vděčíme za hladký běh všech činností České endodontické společnosti. Pro nový výbor je to velká inspirace a zároveň i velký závazek, aby si Česká endodontická společnost udržela vysokou míru profesionality a nabytého respektu v rámci české stomatologie.
Věřím, že tento bulletin je toho prvním důkazem.



Za výbor České endodontické společnosti

Radek Žižka

Stříbrný sponzor

FENIX DENTAL

just Dent

PATÁKOVO s.r.o.

Vystavovatelé

CAMOSCI imaging & innovation

Dentsply Sirona

EVERYDENT KVALITA S RADOSTÍ A PERSPEKTIVOU

eyedent

HENRY SCHEIN® DENTAL

JANOUCH DENTAL

JPS

rodentica

Schafferová



Z 14. kongresu České endodontické společnosti







Dne 17. 9. 2022 se konalo setkání příznivců endodoncie na 14. kongresu České endodontické společnosti. Letos nově v historických prostorách hotelu International v Praze za přítomnosti více než 200 účastníků.

Letošní program zahájil přednáškou dr. Andrey Polov (Ukrajina) na téma ošetření vitální pulpy. Česká endodontická společnost darovala po útoku na Ukrajinu ukrajinské ambasádě 500 000 Kč, pozvání dr. Polova následovalo vedle jeho odbornosti též jako gesto sounáležitosti s Ukrajinou v této pro ni nelehké době.

Následovalo vystoupení dr. Jiřího Kruga, který prezentoval doporučení týkající se retrográdní chirurgické endodoncie, na kterém se shodli zástupci chirurgů a endodontistů (J. Krug, L. Peřinka, R. Žižka). Plné znění doporučení schváleného vědeckou radou ČSK najdete v tomto Občasníku.

Další přednáškou byla původní retrospektivní studie úspěšnosti endodontického ošetření, kterou přednesl dr. Daniel Černý.

Po obědě jsme vyslechli obohacující přednášku dr. Kataríny Cyprichové (Slovensko), která po dlouhé době opět vystoupila na našem kongresu, tentokrát s tématem Lesk a bída Vitapexu, aneb proč je zinkoxideugenol stále „in". Dr. Martin Košťál se zaměřil na procesy předcházející vlastnímu endodontickému ošetření zubů jako na nezbytnou součást úspěšného ošetření. Program uzavíral anesteziolog prof. Vladimír Černý přednáškou o sedaci ve stomatologii.

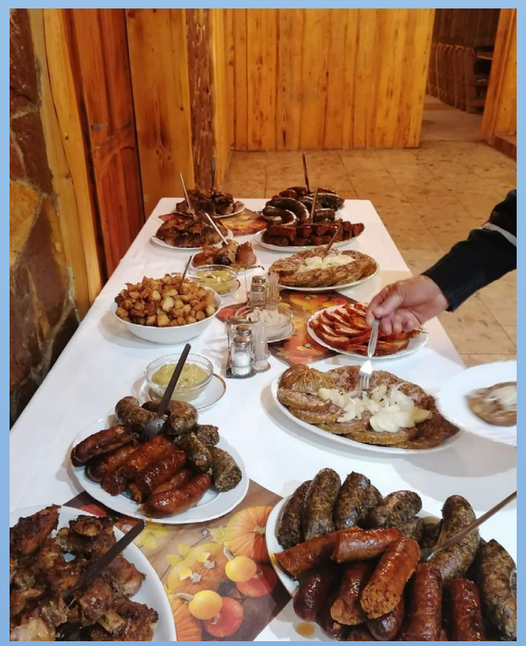
Významným partnerem při organizaci kongresu byli sponzoři, kteří se také přímo zúčastnili akce v předsálí a přilehlých prostorách. Úspěšné odborné setkání jsme zakončili společenským večírkem ve věži hotelu International s krásným výhledem na Prahu.

MUDr. Simona Ságlová, Ph.D.

Výjezdní zasedání Patince

Po několika letech jsme měli možnost opět zavítat na slovensko-maďarské pomezí do blízkosti města Komárno, jelikož výjezdní zasedání podzim 2022 zaštítil dlouholetý člen MUDr. Ján Lužica a organizoval MUDr. Jan Šváb. Hlavní skupina vyrazila napříč republikou v pátek v ranních hodinách. Cesta byla pro většinu členů dlouhá, dobrá nálada se násobila, a tak páteční večer patřil srdečnému přijetí Jána ve sklípku a zabijačkovým delikatesám.
Sobotní program byl dopoledne využit k rekonvalescenci v místním wellness centru, či k prohlídce města Komárna pyšnícího se svou historicky významnou pevností. Odpoledne pokračovalo přednáškou MUDr. Jana Švába s bohatou diskuzí a kazuistikami členů. Každému pak vyšla večerní rovnice, která znamenala bazén + bowling + bar.
Cílem neděle byl návrat domů.

MDDr. Jan Lapiš





Zpravodajské okénko

Zdrogované labutě obsadily pole s mákem

Manželé Pémovi z obce Patince v okresu Komárno si nedokážou poradit s nadrogovanými labutěmi, jež obsadily jejich pole. Labutě požírají celou rostlinu máku, která je toxická, a pak se chovají jako zdrogované.

Jak informoval deník Nový čas, labutě v poli s mákem nakladly vajíčka – a najednou jich tam bylo 150 až 200. Labutě jsou zákonem chráněné a manželé nevědí, jak se jich zbavit. „Volal jsem do České republiky kolegům, ani oni nevěřili. S něčím takovým jsme se ještě na Slovensku nesetkali," říká Bálint Pém, který mák pěstuje už roky.

Nový čas uvedl, že opeřenci se nemohou hýbat, nedokážou létat, jsou jako zdrogovaní a jsou velmi snadnou kořistí pro šelmy. „V principu je to stejné jako s narkomanem. Pokud toho sežerou méně, budou omámené. Ale pokud budou žrát stále to samé, větší a větší dávky, tak zahynou. Předávkují se," vysvětlil přírodovědec Vladimír Topercer.

Hlavním důvodem, proč se labutě na poli usadily, však podle odborníků není mák, ale malé jezírko. „To vzniklo v důsledku velkého množství srážek a podzemní vody, která prosakovala na povrch. Labutěmi se už zabývají ochranáři ze státní ochrany přírody," uvedl Tomáš Ferenčák z ministerstva životního prostředí.

Novinky.cz Ivan Vilček 27. 5. 2023, 11:25
https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-zdrogovane-labute-obsadily-pole-s-makem-40432849#utm_content=ribbonnews&utm_term=patince&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz



https://ct24.ceskatelevize.cz/3593564-labute-pod-vlivem-opia-znicily-urodu-maku-za-ctvrt-milionu-korun-ceka-je-odvykaci-kura

Členská schůze v Praze, volby vedení České endodontické společnosti







Dne 28. 1. 2023 proběhlo v Praze, v hotelu Grandior, první letošní setkání. Z pohledu dalšího fungování společnosti bylo zásadní. Skončilo nám totiž čtyřleté funkční období, a tak bylo nutné zvolit nové zástupce do vedení naší společnosti.

Setkání se však netýkalo jen voleb. Bylo probráno vyúčtování uplynulého kongresu a hospodaření spolku, představeny výroční zprávy členů výboru, schváleny úpravy stanov a projednány další neméně důležité provozní záležitosti. Po obědě se pak uskutečnila poutavá přednáška MDDr. Pavla Podolského na téma využití kalciumsilikátových materiálů v klinické praxi.

Volby

Voleb do vedení společnosti se zúčastnilo celkem 33 členů prezenčně a 3 členové se k nám připojili online, což byla zajímavá a do budoucna velice praktická zkušenosti.

Prezidentem České endodontické společnosti byl zvolen MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.

Členy výboru byli zvoleni: MUDr. Martin Dančík (vědecký sekretář), MDDr. Alexandr Čech (hospodář), MUDr. Michal Bumbálek, Ph.D., MUDr. Hana Zallamnnová, MDDr. Aristotelis Jakovidis (prezident kongresu), MDDr. Gabriel Dekány.

Členy revizní komise byli zvoleni: MDDr. Jan Lapiš, MUDr. Aleksandra Paklos, MDDr. Vít Jiroušek.

Poděkování

Česká endodontická společnost byla založena již v roce 2007. Její vznik a především rozvoj je od počátku spojen s několika neodmyslitelnými osobnostmi. Díky jejich nasazení dnes patří Česká endodontická společnost k uznávaným odborným společnostem. Při letošních volbách se řada těchto osobností rozhodla do výboru dále nekandidovat. Sluší se jim zde poděkovat. Poděkovat nejen za to, že vedli společnost odborně, ale také za to, že se jim podařilo ve společnosti vytvořit a udržet přátelskou, až rodinnou atmosféru.

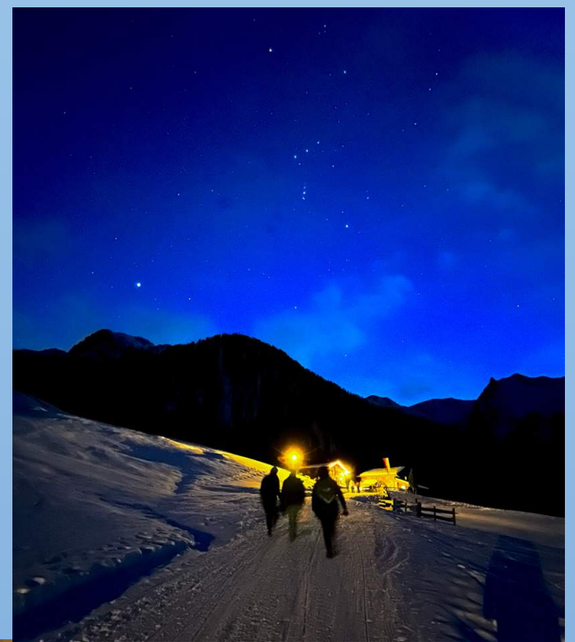
Jménem celé společnosti děkuji odcházejícím členům vedení, jmenovitě doc. MUDr. Luďkovi Peřinkovi, CSc., MUDr. Danielu Černému, Ph.D., MUDr. Simoně Šáglové, Ph.D., MUDr. Janu Švábovi a MUDr. Soně Hüttnerové, za jejich práci. Amicitia nisi inter bonos esse non potest.

MDDr. Alexandr Čech

Zimní setkání v Sand in Taufers

Symaptické městečko v Jižním Tyrolsku se i v roce 2023 stalo soukromou destinací několika členů ČES a jejich rodin. Sportovně-rekreační událost organizoval MUDr. Michal Bumbálek, který nás tak pozval do míst svého bývalého profesního působiště a provedl místními krásami gastronomickými i geografickými.
Využita byla jak lyžarská centra Kronplatz, Alta Badia a místní sympatický Speikboden, tak běžecké areály i sáňkařská dráha.

MDDr. Jan Lapiš







Zpravodajské okénko

Uvolněný balvan v severní Itálii málem rozdrtil projíždějící auto

Jen sekundy a pár metrů dělily od katastrofy lyžařské středisko Speikboden u severoitalské obce Sand in Taufers, když se na přilehlém svahu z ničeho nic objevil uvolněný balvan. Průmyslová kamera zachytila, jak se obří kámen řítí stále větší rychlostí dolů k silnici, po níž v obou směrech jezdila auta.

Balvan jen o metry minul restauraci a přeskočil rovnou doprostřed asfaltové komunikace na místo, kudy před třemi sekundami projelo osobní vozidlo. Dechberoucí videozáznam zveřejnil na sociálních sítích místní svaz dobrovolných hasičů.

Nikdo nebyl zraněn, ale záchranáři, kteří přijeli uvolněný kus skály o velikosti osobního auta s pomocí bagru odklidit, hovoří o „štěstí v neštěstí". K dobrému konci přispěl zřejmě i fakt, že místní lyžařské středisko bylo uzavřené a parkoviště prázdné, protože zimní sezona už skončila.

Průzkum okolních svahů ukázal, že se nad silnicí uvolnil ještě další kus skály, ten ale hasiči mezitím zajistili tak, aby nikoho neohrozil.

Novinky.cz Jaroslav Zbožínek 30. 4. 2023, 7:42
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-uvolneny-balvan-v-severni-italii-malem-rozdrtil-projizdejici-auto-40430195#utm_content=ribbonnews&utm_term=sand%20in%20taufers&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz



https://fb.watch/l-_lnN-VS5/

Víkendové zasedání ČES v Brně









Letošního červnového výjezdu členů ČES se zhostil MUDr. Michal Bumbálek a zorganizoval víkendové zasedání v Hotelu International Brno. Na sobotní odpoledne jsme pozvali MUDr. Radomíra Humplíka ze společnosti Henry Schein, s. r. o.

Prvním bodem programu bylo popsání obrazu periapikálního projasnění slovy MDDr. Radovana Žižky, Ph. D. V rámci večerní přednášky se zaměřil na etiologii vzniku periapikálních projasnění – od počátečních fází při hlubokém kazu až po pokročilejší stav s extraradikulárním biofilmem. Nezůstal pouze u akademických znalostí, ale tyto informace aplikoval do klinické rozvahy při terapii jak primárního, tak sekundárního ošetření kořenových kanálků, aby pravděpodobnost úspěchu ošetření byla co nejvyšší.

Po večeři jsme se odebrali diskutovat rozmanitá témata do baru Don Pintxos na Dominikánském náměstí.

Sobotní dopoledne patřilo klenotu jihomoravské metropole. Mnohé příběhy ze sedmisetleté historie hradu Špilberk vylíčil místní průvodce, který zaujal skvělým přednesem.

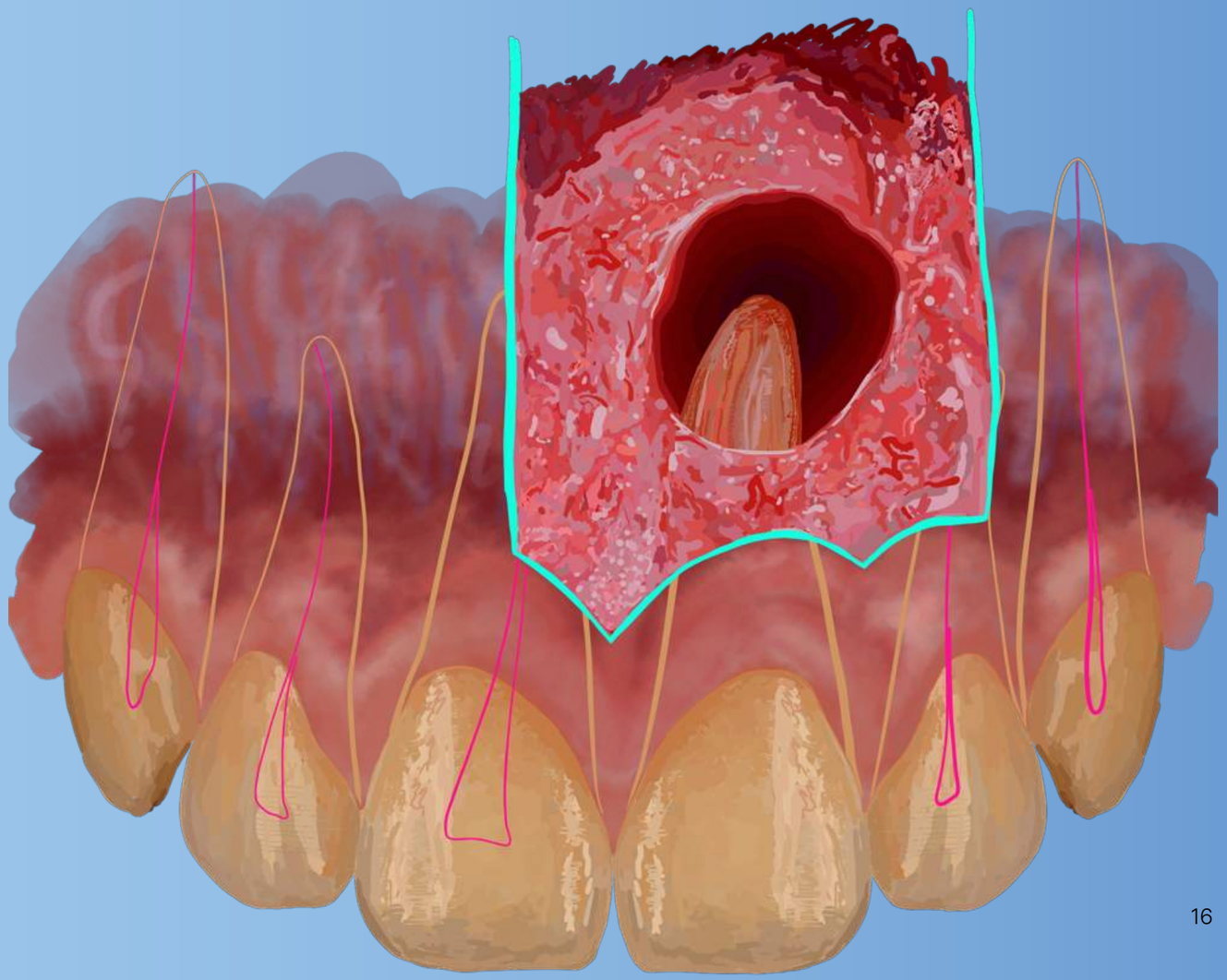
V odpoledním vzdělávacím bloku, organizovaném MUDr. Radomírem Humlíkem, jsme okusili práci s nástroji Endo Edge. Účastníkům byla představena produktová řada endodontických nástrojů a na připravených modelech jsme si mohli prakticky vyzkoušet práci s nimi. Po workshopu byly prezentovány kazuistiky členů ČES.

Večerní diskuze, stejně jako i ty při nedělní snídani, byly ukončením dalšího povedeného víkendu v podání ČES.

MDDr. Jan Lapiš

Retrográdní chirurgická endodoncie (RCHE)

Doporučení přístupu, provedení a hodnocení



Literatura

1. Siqueira JF. Aetiology of root canal treatment failure: why well-treated teeth can fail. Int Endod J. 2001; 34(1): 1–10. doi: 10.1046/j.1365-2591.2001.00396.x

2. Nair PNR, Sjögren U, Krey G, Sundqvist G. Therapy-resistant foreign body giant cell granuloma at the periapex of a root-filled human tooth. J Endod. 1990; 16(12): 589–595. doi: 10.1016/s0099-2399(07)80202-0

3. Cotton T, Geisler T, Holden D, Schwartz S, Schindler W. Endodontic applications of cone-beam volumetric tomography. J Endod. 2007; 33(9): 1121–1132.

4. Low KMT, Dula K, Bürgin W, von Arx T. Comparison of periapical radiography and limited cone-beam tomography in posterior maxillary teeth referred for apical surgery. J Endod. 2008; 34(5): 557–562. doi: 10.1016/j.joen.2008.02.022

5. Kim S, Rethnam S. Hemostasis in endodontics. Dent Clin North Am. 1997; 41(3): 499–511.

6. Mauger MJ, Schindler WG, Walker WA. An evaluation of canal morphology at different levels of root resection in mandibular incisors. J Endod. 1998; 24(9): 607–609. doi: 10.1016/s0099-2399(98)80120-9

7. Gagliani M, Taschieri S, Molinari R. Ultrasonic root-end preparation: Influence of cutting angle on the apical seal. J Endod. 1998; 24(11): 726–730. doi: 10.1016/s0099-2399(98)80162-3

8. Weissman A, Goldberger T, Wigler R, Kfir A, Blau-Venezia N. Retrograde root canal retreatment with prebent ultrasonic files. A retrospective outcome study. Int Endod J. 2019; 52(11): 1547–1555. doi: 10.1111/iej.13176

9. Tsesis I, Rosen E, Schwartz-Arad D, Fuss Z. Retrospective evaluation of surgical endodontic treatment: traditional versusm modern technique. J Endod. 2006; 32(5): 412–416.

10. De Lange J, Putters T, Baas EM, Van Ingen JM. Ultrasonic root-end preparation in apical surgery: a prospective randomized study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 104: 841–845.

11. Rahbaran S, Gilthorpe MS, Harrison SD, Gulabivala K. Comparison of clinical outcome of periapical surgery in endodontic and oral surgery units of a teaching dental hospital: A retrospective study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001; 91(6): 700–709. doi: 10.1067/moe.2001.114828

12. Frank RJ, Antrim DD, Bakland LK. Effect of retrograde cavity preparations on root apexes. Endod Dent Traumatol. 1996; 12(2): 100–103. doi: 10.1111/j.1600-9657.1996.tb00105.x

13. Johnson BR, Fayad MI, Witherspoon DE. Periradicular surgery. In: Hargreaves KM, Cohen S, Berman LH. Cohen's pathways of the pulp. 10. vydání. St. Louis, MO.: Mosby Elsevier; 2011, 755.

Cíl ošetření
Ošetření zubu s endodontickou lézí, který není možné nebo výhodné ošetřit konvenčním (ortográdním) endodontickým přístupem. Je odstraněna apikální část kořene, v kořenovém kanálku zkráceného kořene preparována kavita a ta zaplněna výplňovým materiálem. Cílem je dekontaminace kořenového systému a jeho následné hermetické uzavření. To vše ve snaze zamezit iritaci periapikální oblasti bakteriemi a jejich produkty z infikovaného kořenového kanálku. Ověřením úspěchu je zhojení periapikálního defektu kostí a obnovení periodontální štěrbiny, aniž dojde ke zhoršení stability zubu.

Etiologie
Příčina chronické apikální periodontitidy je mikrobiální. Bakterie se mohou nacházet intraradikulárně jako důsledek nekompletní dekontaminace kořenového systému, nebo v případě dlouhotrvajícího procesu mohou vytvořit biofilm i extraradikulárně. Stimulace mikroorganismy, jejich toxiny a rozpadovými produkty dřeně vede k zánětlivé reakci organismu a vytvoření periapikální léze [1].

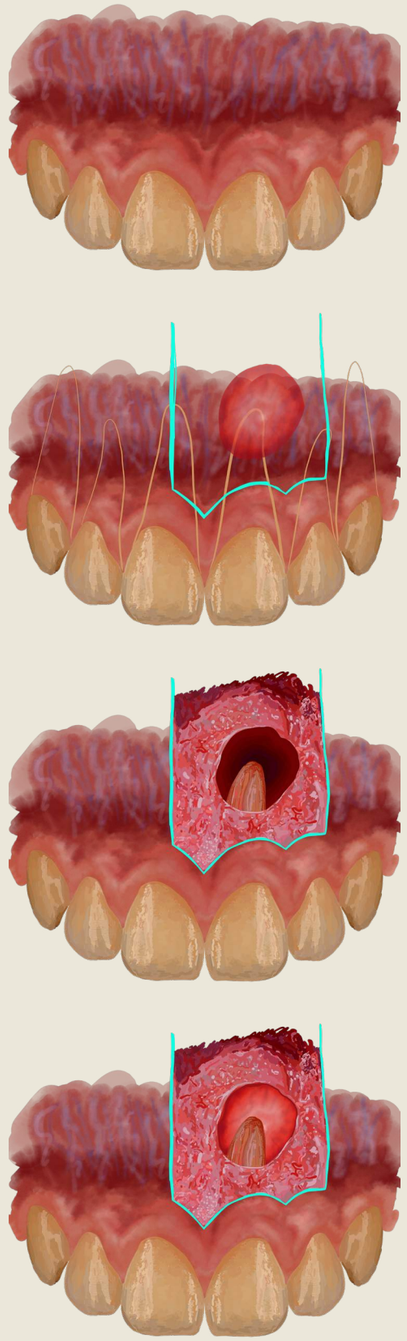
Indikace RCHE
1) rentgenologický nález odpovídající apikální periodontitidě a s tím spojené klinické obtíže, při současné obstrukci kanálku, kterou nelze ortográdně odstranit či obejít, anebo hrozí zeslabení stěny kořene či tvrdých zubních tkání korunkové části nutných pro protetické ošetření;
2) cizorodý materiál (kořenová výplň nebo fragment nástroje) přetlačený přes for. apicale, jenž není možné ortográdně vyjmout [2];
3) přetrvávající nebo nově přítomné obtíže po ortográdním endodontickém či reendodontickém ošetření nebo po nesprávně provedené chirurgické endodoncii, kdy úspěšnost opakovaného ortográdního ošetření je sporná;
4) perforace kořene, kterou nelze ošetřit ortográdně;
5) nutnost vizualizace apikální oblasti, potřeba histologického vyšetření, podezření na kompletní vertikální frakturu kořene (VRF), odstranění fragmentu nástroje;
6) přítomnost vývojové anomálie tvaru korunky nebo kořene zubu, kdy by ortográdní ošetření vedlo k výraznému oslabení tvrdých zubních tkání.

Kontraindikace RCHE
1) zub s výhledem úspěšného ortográdního ošetření kořenových kanálků;
2) sporný biologický faktor zubu (tvrdé zubní tkáně, parodont), VRF;
3) vysoké riziko poškození důležitých anatomických struktur (výstup n. mentalis nebo průběh n. alveolaris inf.); pozn.: intimní vztah kořene k antrum Highmori není kontraindikací;
4) nepříznivé anatomické poměry (anatomie kořene či okolních struktur);
5) závažná systémová onemocnění a technická omezení (omezené otevírání úst, mikrostomie, pacienti po operaci krční páteře).

Klinické vyšetření
Ke stanovení prognózy zubu je zapotřebí klinické vyšetření zubu (biologický faktor, funkční důležitost, kvalita okrajového uzávěru, časový údaj o provedeném endodontickém ošetření, dostupnost starší rtg dokumentace), zhodnocení stavu parodontu (přítomnost parodontálních chobotů, a to zvláště solitárních, pohyblivost zubu, přítomnost artikulačního traumatu), pátrání po fraktuře kořene jako možné příčině selhání konvenční endodontické léčby (spára kořene, záznam při endodontickém ošetření); z technického pohledu je nezbytná kontrola možnosti polohování pacienta a volný přístup do oblasti plánovaného výkonu.

Rentgenové vyšetření
V rámci rentgenového vyšetření hodnotíme kvalitu endodontického a postendodontického ošetření, včetně možných komplikací endodontického ošetření, a rozsah a umístění projasnění. Intraorální rentgenogram zobrazí periapikální oblast ve dvourozměrném obraze. Vztah hrotu kořene a čelistní dutiny nebo mandibulárního kanálu lze lépe odměřit na panoramatickém snímku čelistí. Pro potřeby přesného odměření patologického nálezu od sousedních anatomických struktur a lepší naplánování chirurgického přístupu je vhodné provést CBCT vyšetření [3, 4]. Rtg obraz je nutno zhotovit tak, aby byla zobrazena celá léze.

Přístrojové vybavení
Použití zvětšení s dostatečným osvětlením je podstatné pro dosažení optimálních výsledků. Především u zubů v distálním úseku je použití operačního mikroskopu výhodné a v případě molárů nezbytné. Podmínkou správně provedeného mikrochirurgického výkonu je operační technika a nástrojové vybavení (piezo koncovky, speciální instrumentárium).



Praktické provedení
Lokální anestezie

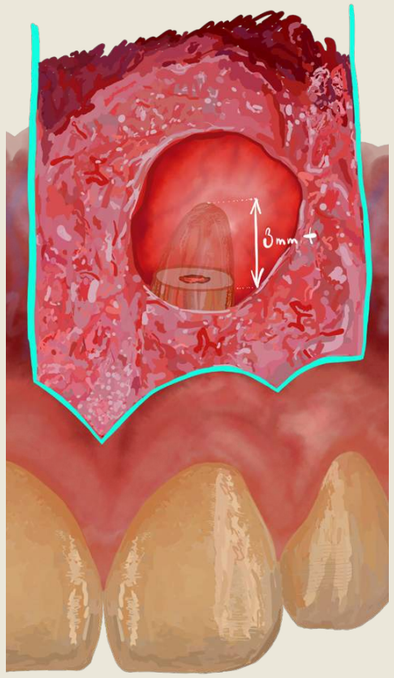
Lokální anestezie zajišťuje nejen bezbolestný výkon, ale taktéž i vazokonstrikci a hemostázu, jež je nutná pro dobrý přehled operačního pole. Je vhodné využít anestetika s vyšší koncentrací adrenalinu, pokud nám to celkový zdravotní stav pacienta umožní [5].

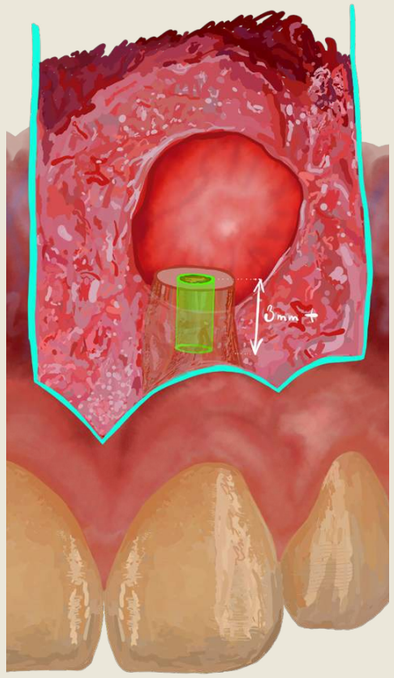
Přístup ke kořenovému hrotu

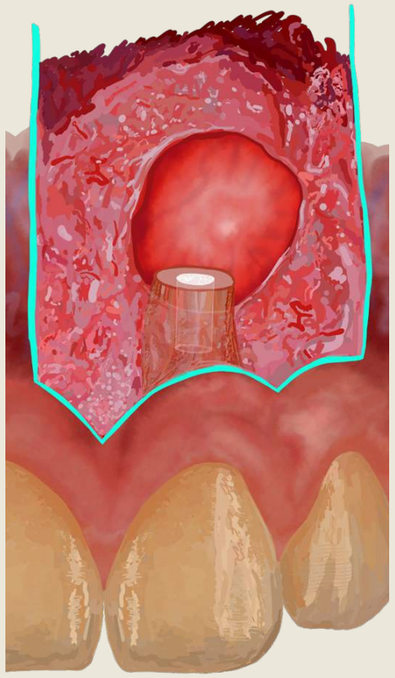
Incise je vedena pokud možno v keratinizované sliznici, ale její přesné umístění závisí na klinickém nálezu a anatomii kořene/ů na rentgenovém zobrazení. Preparace/rozšíření kostního okna vrtákem či ultrazvukovou koncovkou musí být dostatečné, aby bylo možné odměřit a kolmo oddělit apikální část kořene, dobře vizualizovat kostní kryptu pro lepší přehled operačního pole. Také aby se dalo z kostní krypty dobře odsávat savkou, a především kolmo do kanálku zavést koncovky a aplikační nástroje pro preparaci a zaplnění kanálků.

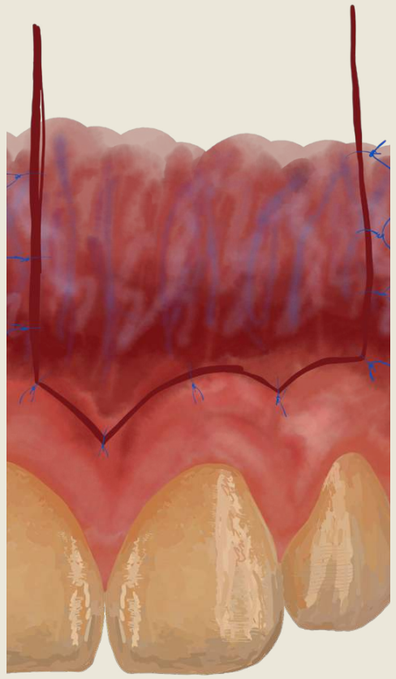
Periradikulární kyretáž

Úvodní odstranění granulační tkáně z periapikální oblasti je výhodné pro přehlednost operačního pole a ke zmírnění krvácení. Vitální vazivovou tkáň v blízkosti stěny kořene není nutné z kostní krypty odstraňovat. Resekcí zkrácený kořen čnící do dutiny v kosti není zapotřebí ani kyretovat. Pokud dutina zasahuje do blízkosti hrotu sousedního vitálního zubu, není vhodné tuto část plně exkochleovat. Odstraněnou tkáň je vhodné histologicky vyšetřit.









Resekce kořenového hrotu

Zkrácení hrotu kořene v délce přibližně 3 mm by mělo být vedeno co nejvíce kolmo na dlouhou osu kořene (maximální odstranění apikální delty a minimální expozice dentinových tubulů), ale tak, aby bylo možné zavést do kanálku/ů preparační piezo koncovky [6, 7]. I když větší část kořene není krytá kostí a je exponována do dutiny, nedoporučuje se odstraňovat více než zmíněné 3 mm apikální části kořene. K resekci kořenového hrotu je vhodná kostní fréza či piezo koncovka, a to vždy se současným chlazením. Resekovanou plochu kořene je nutné pečlivě vyšetřit za pomoci barvicího indikátoru. Taktéž je nutné zkontrolovat i povrch kořene, zdali není přítomno vyústění laterálního kořenového kanálku nad resekční plochou. Tato kontrola by měla být provedena za co největšího dosažitelného zvětšení. Přitom se pátrá po spojkách kanálků (istmus), prověří se kvalita předchozího zaplnění kanálků (hermetičnost) a celistvost dentinu (lomy, praskliny).

Retrográdní preparace kořenového kanálku

Preparace v kořenovém kanálku musí být vedena v jeho dlouhé ose minimálně 3–4 mm do hloubi [8]. Pokud revidujeme již zkrácený hrot kořene nebo je špička kořene z jiného důvodu zkrácená či je v kanálu ortográdně zaveden dlouhý kovový čep, je možná i mělčí preparace v kanálu (minimálně 2 mm). V některých případech lze odpreparovat apikální část intrapulpálního čepu, nebo vytvořit prostor kolem něj. Současné studie prokazují, že k vysoké účinnosti preparace je použití vhodné ultrazvukové koncovky nezbytné [8, 9, 10, 11]. Nízká intenzita ultrazvuku a lehký dotyk piezo koncovky při trvalém chlazení minimalizuje vznik prasklin [12]. Stěny kanálku by měly být zcela očištěny od kořenové výplně a ke kontrole přítomnosti ponechaného infikovaného dentinu či prasklin je nutné opět použít barvení a retrográdního zrcátka. Kavitu není zapotřebí vyplachovat žádným chemickým prostředkem.

Zaplnění retrográdní kavity a uzavření rány

Před zaplněním kanálku je nutné z kostní krypty odstranit zbytky kořenové výplně a piliny z preparovaného dentinu. Do vysušené retrográdní kavity kořene je aplikována a kondenzována kořenová výplň bez ponechání přebytku na resekované ploše. Klinicky se jeví jako nejvíce úspěšné kalciumsilikátové materiály [13]. A to ať už materiály na bázi portlandského cementu (např. ProRoot MTA), nebo vycházející z určité složky portlandského cementu (povětšinou trikalciumsilikátu). Materiály mohou být ve formě cementu nebo předmíchané. Ostatní materiály jako super EBA (kyselina etoxybenzoová), skloionomerní cementy, kompozita (s dentinovým adhezivem), zinkoxideugenolové cementy nemají tak kvalitní vlastnosti jako kalciumsilikátové materiály, a jsou proto spojeny s nižší úspěšností vyhojení kostního defektu. Amalgám není vhodný jako retrográdní kořenová výplň.

Preparace kavity a její zaplnění je nezbytné vždy tam, kde při předcházejícím ošetření byl jako součást kořenové výplně použit gutaperčový čep. A to bez ohledu na to, jak kvalitní apikální výplň byla provedena. Při resekování kořenového hrotu dochází k narušení těsnosti gutaperčové kořenové výplně. Retropreparace a zpětné zaplnění nejsou nezbytné pouze v tom případě, kdy apikální část kanálku byla ortográdně zaplněna kalciumsilikátovým materiálem. Ten se při resekování objemově nedeformuje a těsnost kořenové výplně není narušena. V těchto případech vždy kontrolujeme, aby po resekci kořenového hrotu bylo evidentní, že nepoškozená kořenová výplň zcela vyplňuje kanál bez netěsností a dentin nejeví známky infikování (nahnědlá barva). Tenký černý lem v okolí kořenové výplně kalciumsilikátového cementu je způsoben přítomností oxidu bizmutitého a není známkou nedostatečné dekontaminace kořenového kanálku. Samotná periapikální kyretáž bez následné resekce kořenového hrotu je výkon, který má minimální medicínské opodstatnění (např. odstranění granulomu u dobře zaplněného a výrazně zkráceného kořene, kde opětovným zkrácením hrozí destabilizace zubu).

Resekce kořenového hrotu bez současné retropreparace a zpětného zaplnění kořenovým materiálem, jakkoliv dobře zaplněného kanálku materiálem jiným než kalciumsilikátovým, není považována za ošetření lege artis.

K rozhodnutí o užívání antibiotik k zábraně pooperační infekce je vždy zapotřebí individuálního přístupu.

Vyplnění kostní krypty augmentačním materiálem před uzavřením rány není vhodné (nelze s odstupem sledovat hojení kostního defektu). Pokud je rozsah kostního defektu výrazný anebo probíhá skrz celý dásňový výběžek, je vhodné dutinu augmentovat až v odděleném operačním výkonu.

Hodnocení výsledku

Sledování úspěšnosti ošetření probíhá jak klinicky, tak rentgenologicky. Klinické zhojení se rovná absenci bolesti, píštěle, otoku, citlivosti inkriminované krajiny na pohmat a zubu na poklep. Po operaci zhotovíme intraorální rentgenogram. Nález pak porovnáváme s rentgeny zhotovenými při kontrolách s odstupem variabilním podle rozsahu defektu, zdraví a stáří pacienta a náročnosti chirurgického výkonu, obvykle po 6–8 měsících od operace a poté po dalších 12 měsících do doby, kdy je patrné kompletní zhojení. Úspěšně zhojené léze nevyžadují další kontrolní vyšetření. Detailněji je hodnocení operačního výsledku klasifikováno jako: 1) úspěšné (bez klinické symptomatologie a vyhojený kostní defekt na rentgenovém zobrazení); 2) nekompletní (bez klinické symptomatologie a zmenšený nález na rentgenovém snímku); 3) nejisté (bez klinické symptomatologie a přetrvávající nález na rentgenovém snímku přibližně ve stejném rozsahu); 4) neúspěšné (nestabilní klinická symptomatologie a přetrvávající nález na rentgenovém snímku). Pro hodnocení zubu z hlediska fokální infekce jsou akceptovatelné stavy 1) a 2).

Při dodržení klinického protokolu je retrográdní chirurgická endodoncie velmi prediktabilní výkon s vysokou úspěšností porovnatelný s ortográdním reendodontickým ošetřením. Jedná se o velmi vhodný výkon vedoucí k zachování zubu zvláště v případech, kdy ortográdní reendodontické ošetření má sníženou úspěšnost, nebo je technicky neproveditelné.

Setkání s ČES stopou

5. kongres Slovenské endodontické společnosti

Dne 3. 6. 2023 se konalo setkání příznivců endodoncie na 5. kongrese Slovenské endodontické společnosti (SES).
Letos se kongres konal v prostorách hotelu Doubletree by Hilton v Bratislavě za přítomnosti více než 160 účastníků. ČES dostala od bratrské společnosti dvě VIP pozvání se kongresu účastnit. Milerádi jsme je využili společně s Dr. Milanem Kraľovičem.

Letošní program zahájil téměř 3hodinovou přednáškou rozdělenou na dva bloky prof. Frances Mannocci (Itálie) na téma, co dělá endodontické ošetření náročné, po přestávce pak pokračoval úskalími výběru mezi reendodontickým ošetřením a periapikální chirurgií.

Následovalo vystoupení dr. Anny Macurové (Slovensko), která prezentovala své zkušenosti s endodontickým ošetřením dočasných zubů.

Po obědě jsme vyslechli obohacující přednášku Dr. Rudolfa Novotného (Slovensko), o různých formách přímé postendodontické rekonstrukce zubu pomocí FRC.

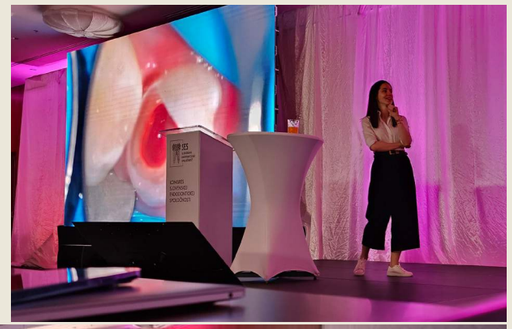
Dr. Piotr Puchala (Polsko) se zaměřil v poslední přednášce kongresu na řešení zalomeného kořenového nástroje v kanálku pomocí rozličných metod.

Souběžně s přednáškami probíhala v sousedním sále také čtyři kola workshopů vždy po 14 účastnících. První dva workshopy vedl dr. Puchala a mohli jsme si vyzkoušet vyjmutí fragmentu pomocí BTR Pen. Druhé dva workshopy týkající se použití biokeramických AH + sealerů vedl prof. Mannocci.

Významným partnerem při organizaci kongresu byli sponzoři, kteří se také přímo zúčastnili akce v předsálí a přilehlých prostorách.

Úspěšné odborné setkání bylo zakončeno neformální večeří v restauraci hotelu Hilton.

MDDr. David Fuller





Ostravská přednáška o periapikální patologii

Začátkem května, 4. 5. 2023, se čtyři zástupci České endodontické společnosti zúčastnili přednášky, kterou organizovala Fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci se společností Interperio v Třebovickém mlýně v Ostravě. Zvolený čas, čtvrteční večer, přilákal asi 35 účastníků. Už podle názvu Periapikální patologie z pohledu endodontisty a maxilofaciálního chirurga bylo patrné, že půjde o velmi zajímavé téma na hranici našich oborů.

Prvním přednášejícím byl MDDr. Arnošt Onderka a jako stomatochirurg svou část zaměřil převážně na patologii z oblasti maxilofaciální onkologie. Prezentoval velké množství kazuistik – jak ameloblastomy, pomalu rostoucí benigní tumory ektodermálního původu, tak i častější nálezy jako odontogenní keratocysty. Nastínil možnosti terapie a rekonstrukce velkých obličejových defektů.
V druhé půlce večera prezentoval MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., svůj endodontický pohled. Přednáška obsahovala podrobné rozdělení periapikální patologie na absces, granulom a cysty, které mohou být pravé a takzvané pocket neboli bay cysty. Popsal teorie jejich vzniku a proliferace. Dr. Žižka se věnoval přítomnosti epitelové tkáně, Malassezových epiteliálních ostrůvků, extraradikulární infekce nebo také přítomnosti cizích těles, které mohou vyvolat velkobuněčnou zánětlivou reakci. Připomněli jsme si nejen poznatky z histopatologie, ale i klinické důvody, proč endodontická léčba selhává.
Věřím, že takovýchto odborných setkání a seminářů bude i nadále přibývat, aby se endodoncie a maxilofaciální chirurgie mohly vzájemně inspirovat a spolupracovat na poskytování nejlepší možné péče pacientům.

MUDr. Martin Dančík





V dalším plánu letošního roku

7. 9. 2023	Bienální kongres ESE, Helsinky, Finsko
16. 9. 2023	15. výroční kongres ČES, Grandhotel International, Praha
1.-3. 12. 2023	Výjezdní zasedání ČES, Luhačovice

Data k uložení v roce 2024

20. 1. 2024	Členská schůze ČES, Praha
9.-11. 6. 2024	Výjezdní zasedání ČES
22. 9. 2024	16. výroční kongres ČES
24. 11. 2024	Výjezdní zasedání ČES

T	C	P	R	E	D	E	N	T	I	N	L	K	E	P
R	Y	H	E	R	T	W	I	G	Z	U	C	T	N	U
E	S	O	M	L	I	F	O	I	B	A	M	N	D	R
P	T	T	A	T	D	E	V	U	B	R	A	E	O	U
A	A	O	E	E	M	C	T	G	E	O	L	M	S	L
N	E	K	R	Ó	Z	A	U	E	C	T	A	E	O	E
A	Č	R	E	P	A	T	U	G	A	K	S	C	N	N
C	H	E	D	S	T	R	Ö	M	K	A	S	A	O	T
E	M	U	I	T	N	O	D	O	I	R	E	P	R	A

V	N	Á	Č	E	S	P	S	N	F	T	Z	R	E	U
E	T	Á	S	E	C	S	B	A	I	X	I	I	D	T
M	C	H	L	O	R	N	A	N	X	E	C	T	A	O
F	B	A	A	P	S	A	E	K	E	P	N	S	E	K
Y	C	O	L	T	N	R	S	T	P	L	I	X	R	L
Z	A	L	O	M	I	T	G	Ú	A	U	R	E	P	Á
É	T	P	K	E	L	Á	N	A	K	P	V	E	S	V
M	M	B	2	F	I	B	R	O	B	L	A	S	T	S

Použitá slova:

absces
apexifikace
autoklav
biofilm
caries
cbct
cement
cysta
dentikl
edta
emfyzém
exstirpace
fibroblast
fraktura
gutaperča
hedström
hertwig
kavitace
krev
lalok
malassez
mta
nekróza
otok
patence
periodontium
plán
sulb
predentin
pulpextraktor
pulpotomie
purulenta
rentgen
sprejader
sterilizace
stop
sukl
transportace
trepanace
tubul
tugback
zalomit

Název	Občasník ČES
Autoři	MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., MUDr. Simona Ságlová, Ph.D., MDDr. Jan Lapiš, MDDr. Alexandr Čech, MDDr. David Fuller, MUDr. Martin Dančík
Vydavatel	Česká endodontická společnost, z.s., Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Datum vydání	2023
Autorská práva	Česká endodontická společnost, z.s., Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Vyrobila	Tiskárna Kartis+Co s.r.o., Borovského 14/717, 734 01 Karviná - Ráj

Česká
Endodontická
Společnost

OBČASNÍK